

6. 电解质不能直接加入脂肪乳剂中。否则其中的阳离子可中和脂肪颗粒上磷脂的负电荷,使脂肪颗粒相互靠近,发生聚集和融合,最终导致水油分层。一般控制一价阳离子浓度 $<150\text{mmol/L}$,镁离子浓度 $<3.4\text{mmol/L}$,钙离子浓度 $<1.7\text{mmol/L}$ 。

7. 配好的 3L 输液袋上应注明配方组成、营养液总液量、输注途径、床号、姓名及配制时间和配置者姓名等。

第四节 肠外营养的应用

一、肠外营养的适应证

An indication for parenteral nutrition can be short bowel syndrome. The most important feature of this syndrome is insufficient absorption of nutrients, indicating the need for parenteral nutritional support. Multiple organ failure, often caused by sepsis, is a condition in which several organs malfunction or do not function at all. In this situation complete or supplementary parenteral nutrition is indicated. Another indication for parenteral support consists of entero-cutaneous fistulas, especially high output fistulas, which are often located proximally in the small bowel. An adynamic ileus, another indication for parenteral support, is characterized by lack of peristalsis and passage. Patients with chronic bowel obstruction also require parenteral nutrition. Indications for parenteral feeding are listed in Box 10-4-1.

Box 10-4-1 Indications for parenteral nutrition

- Mucositis following chemotherapy
- A minority of patients with inflammatory bowel disease where enteral nutrition has failed to prevent or reverse malnutrition (i. e. severe malabsorption)
- Patients with multiorgan failure where nutritional requirements cannot be met by the enteral route alone
- Intestinal atresia
- Radiation enteritis
- Motility disorders such as scleroderma or chronic idiopathic intestinal pseudo obstruction syndromes
- Extreme short bowel syndrome of any etiology

肠外营养的基本适应证是胃肠道功能障碍或衰竭的患者。凡患者存在营养不良,或估计 1 周以上无法正常饮食者,都有肠外营养治疗的指征。凡是需要营养支持,但又不能或不接受肠内营养支持的患者均为肠外营养支持的适应证。许多外科情况,例如营养不良者的围术期、瘫痪、大面积烧伤,炎性肠道疾病、克罗恩病或溃疡性结肠炎的急性期,重症急性胰腺炎等疾病的病程多长达 1 个月以上,过早恢复肠内营养可能使病情加重,故应采用肠外营养,以维持机体营养需要。美国肠内肠外营养支持协会(ASPEN)提出应用肠外营养支持的准则,按疗效分为:①疗效显著的适应证;②肠外营养对治疗有益的中度适应证;③肠外营养支持疗效不肯定的弱适应证;④肠外营养的禁忌证。

(一) 消化系统疾病

胃肠需要充分休息或消化吸收障碍时,需肠外营养支持。

1. 消化道瘘 高位小肠瘘因所进食物会从瘘口排出,造成营养物质吸收障碍,而且大量消化液的丢失使患者发生脱水及电解质紊乱,加之肠瘘患者常同时伴有腹腔感染及脓肿,使机体进一步耗竭,短期内即可导致死亡。肠外营养支持不仅可以供给充足的营养,而且还可使消化道休息,大大减少消化液的分泌与丧失,提高组织愈合能力。

2. 炎症性肠病 包括溃疡性结肠炎与克罗恩病等。肠外营养可减轻腹部不适与腹泻等症状,对于肠道炎性疾病引起生长发育停滞的儿童,在给予充分的肠外营养支持后,能够恢复正常的生长发育。

3. 短肠综合征 广泛小肠大部切除的患者很难在术后短期内经胃肠道吸收充足的营养物质,可致严重的营养不良。肠外营养可显著改善患者营养状况,并给予肠道适应术后状况及恢复功能的时间。

4. 中、重症急性胰腺炎 禁食可使慢性复发性胰腺炎患者减少呕吐与腹部疼痛等症状,肠外营养可满足禁食时机体的营养需要。

5. 胃肠道梗阻 如贲门癌、幽门梗阻、高位肠梗阻、新生儿胃肠道闭锁等。

6. 严重营养不良伴胃肠功能障碍者。

7. 其他 一些疾病可影响小肠的运动与吸收功能,如长期顽固性的恶心呕吐、严重腹泻、硬皮病、系统性红斑狼疮、小肠黏膜萎缩、放射性肠炎、炎性粘连性肠梗阻、胃肠活动减弱、食管贲门失弛缓症、多发性肠瘘以及广泛的、不易手术切除的克罗恩病等。这些患者可依靠肠外营养维持良好的营养状态,长期家庭肠外营养者能保持较好的生活质量。

(二) 大面积烧伤

严重复合伤、破伤风、大范围的手术等患者处于强烈的应激状态,代谢旺盛,同时消化功能受到抑制,不能经胃肠道补充足够营养素。与分解代谢有关的氮、钾、磷等从渗出液中大量流失。应激状况下,儿茶酚胺、胰高糖素、生长激素与糖皮质激素等分泌增加,蛋白质及脂肪分解、糖异生活跃,水钠潴留。及时给予肠外营养可减少继发感染、低蛋白血症、多脏器损害等并发症。

(三) 严重感染与败血症

持续高热与食欲减退使能量需求与代谢率明显增加,而营养摄入则明显不足。临床上可见患者因负氮平衡和代谢亢进而日趋消瘦,并出现低蛋白血症,进而导致免疫功能降低,抗感染能力下降。此类患者应注意尽早给予肠外营养支持治疗。

(四) 术前准备

术后的死亡率与营养不良状况密切相关,对于营养不良、需进行大的胸腹部手术的患者,应给予肠外营养支持,建议术前营养支持 7~10 天;对于存在感染并发症倾向的骨科与颅内手术等患者也提倡加强营养支持,有效地维持患者的营养状况,防止病情进一步恶化,降低手术治疗的死亡率。

(五) 急性肾功能衰竭

尿毒症时,蛋白分解增加并易合并感染。透析时营养物质在体外丢失,诸多因素均可促使患者迅速出现明显的营养障碍,从而使已损伤的肾功能更不易恢复。在严格控制体液总量、钠盐与钾盐含量等条件下给予肠外营养,有助于缩短病程,减少并发症。

(六) 妊娠剧吐与神经性厌食

早孕反应所致的严重恶心、妊娠剧吐超过 5~7 天时,应给予肠外营养支持,以保护孕妇

及胎儿。神经性厌食可以引起严重营养不良,特别是消化道分泌受抑制所引起的营养不良难以纠正,应用肠外营养支持。

(七) 神志不清,肺内吸入高度危险倾向,腹膜炎,肿瘤化疗或放疗引起的胃肠道反应等短期内不能由肠内获得营养的患者。

(八) 家庭肠外营养支持

家庭肠外营养支持指征虽然在原则上与住院患者基本相同,但仍有一些特殊的适应证。对于病情稳定,能起床活动和基本生活自理,可以出院继续治疗,但有不能通过胃肠道吸收或不能充分吸收营养物质可以满足机体营养需要的患者,均适合做肠外营养。如:短肠综合征,晚期肿瘤患者,炎性肠道疾病,放射性肠炎及丧失吞咽功能、其他原因所致的肠梗阻等患者。

二、肠外营养的禁忌证

Since delivery of parenteral nutrition requires a catheter in a central vein, parenteral nutrition is contraindicated in patients with hemodynamic instability, since they have an increase risk of pneumothorax. Percutaneous puncture of a central line is also contraindicated in patients with clotting abnormalities since they have an increased risk of bleeding.

经过多年的临床实践,对肠外营养的应用范围及并发症的发生和处理进行了广泛的研究,认为目前阶段应用肠外营养的禁忌证有:严重循环、呼吸功能衰竭,严重水、电解质平衡紊乱,肝、肾功能衰竭等。

下列情况应慎用肠外营养:

1. 无明确治疗目的或已确定为不可治愈而盲目延长治疗者 如广泛转移的晚期恶性肿瘤伴恶病质的患者,生活质量差、任何治疗方法均无明显改善作用,此时肠外营养也无明显益处,反而会增加患者生理和经济的负担。
2. 胃肠道功能正常或有肠内营养适应证者 对接受肠外营养支持的患者,应注意观察胃肠道功能的恢复情况,及时由肠外营养过渡到肠内营养。
3. 患者一般情况良好、预计需要肠外营养时间少于5天者。
4. 原发病需立即进行急诊手术者。
5. 预计发生肠外营养并发症的危险性大于其可能带来的益处者。
6. 心血管功能紊乱或严重代谢紊乱尚未控制或处于纠正期间。
7. 脑死亡或临终或不可逆昏迷。

三、肠外营养的并发症

Complications associated with parenteral nutrition can be mechanical, metabolic, or infectious. The most frequent infectious complication of parenteral nutrition is catheter-related sepsis. The incidence varies from 12% to 25%. The catheter hub is the most common site of origin of organisms who cause catheter tip infection and bacteremia. Performed strictly according to protocol, catheter care achieves a significant decrease in infectious complications. Possible differences in infectious risk between single or multi-lumen catheters remain controversial. Other factors that can contribute to catheter sepsis are catheter insertion, production and delivery of the parenteral solution, and thrombogenic properties

of the catheter related to the texture of the catheter and the tendency of platelets to adhere to it.

It is important that patients are not fed in excess of their requirements parenterally as this can lead to a variety of metabolic problems such as: (1) disorders in fat metabolism(hypertriglyceridemia); (2) glucose metabolism(hyperglycemia); (3) electrolyte(sodium, potassium) disorders and mineral imbalances(magnesium, phosphate); (4) hepatic disorders.

对肠外营养并发症的认识和防治,直接关系着其实施的安全性。根据其性质和发生的原因可归纳为四大类。大多数并发症是可以预防 and 治疗的。

1. 置管并发症 这类并发症均与中心静脉导管的置入技术及护理有关。常见有气胸、血胸、血肿,损伤胸导管、动脉、神经以及空气栓塞等。此外,护理不当也可造成导管脱出、折断等并发症,借助 X 线检查可确定深静脉导管放置部位,若能严格按照操作规程和熟练掌握操作技术,这些并发症是可以预防的。出现静脉血栓可用尿激酶或链激酶等作纤溶处理。在每升肠外营养制剂中加 3000U 肝素可减少血栓形成机会。

2. 感染并发症 在导管置入、营养液配制、输入过程中极易发生感染。导管性败血症是肠外营养常见的严重并发症。营养液是良好的培养基,可使细菌迅速繁殖,导致脓毒血症,因此每一步骤必须严格按无菌操作技术规定进行。在中心静脉营养治疗过程中突然出现寒战高热,而无法用其他病因来解释时,则应考虑导管性败血症。应立即拔除旧导管,作导管头及血细菌培养(包括真菌培养),同时辅以周围静脉营养。必要时应根据药物敏感试验配合抗生素治疗。导管性败血症的预防措施包括:①置管过程的严格无菌技术;②在超净工作台内配制营养液;③采用全封闭式输液系统;④定期消毒穿刺点皮肤并更换敷料等。

3. 代谢并发症 这类并发症多与对病情动态监测不够、治疗方案选择不当或未及时纠正有关。可通过加强监测并及时调整治疗方案,予以预防。

(1)液体量超负荷:液体量过多可致心肺功能不堪负荷而出现衰竭症状。对老年人、心肺功能与肾功能不全者,应特别注意控制液体输入量与输液速度。

(2)糖代谢紊乱:常表现为低血糖反应、高血糖反应、高渗性非酮性昏迷。大多数营养不良患者治疗前已存在进食量少,胰岛素分泌量不足,胰高糖素等升血糖激素分泌增多等状况。葡萄糖输入过多、过快,外源性胰岛素补充不足,则会出现高血糖。此时,可对营养液中糖与脂肪的比例加以调整,或在葡萄糖溶液中加入适量胰岛素。高血糖所致的高渗状态可使脑细胞脱水,出现高渗性非酮性昏迷。严重高血糖反应发生后应立即停用肠外营养,改用低渗盐水(0.45%)以 250ml/h 的速度输入,以降低血浆渗透压。

长期肠外营养治疗的患者,如突然停止输液,或感染控制后组织对胰岛素敏感度突然增加,导致反应性低血糖症。低血糖反应是由于持续输入高渗葡萄糖,刺激胰岛细胞增加胰岛素分泌,使血中有较高的胰岛素水平。若突然停用含糖溶液,有可能导致血糖急性下降,发生低血糖反应,甚至低血糖性昏迷,严重者危及生命。因此,肠外营养时切忌突然换用无糖溶液。为安全起见,可在高糖液体输完后,以等渗糖溶液维持数小时过渡,再改用无糖溶液,以免诱发低血糖。

高血糖反应系指在开始应用肠外营养时,输入的葡萄糖总量过多或速度过快,致单位时间内摄入的糖量过多,超出机体耐受的限度。特别是患者有糖尿病、隐性糖尿病或感染等情况时,易导致高血糖的发生。因此,应控制糖的输入速度,开始阶段应控制在 $0.5\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{h})$

以内,并监测血糖和尿糖,以后逐步增加到 $1 \sim 1.2 \text{g}/(\text{kg} \cdot \text{h})$ 。对需要葡萄糖量较大、有隐性或明显糖尿病的患者,适当补充外源性胰岛素可减少高血糖反应的发生。

高渗性非酮性昏迷常因高血糖未及时发现并控制,导致大量利尿、脱水,以至昏迷。此症因患者糖代谢正常,血中无过量酮体存在,一旦发生,立即给予大量低渗盐水以纠正高渗环境,同时加用适量胰岛素以降低血糖即可。治疗即要积极及时,又要防止过量输入低渗盐水,以免造成脑水肿。

对于应用肠外营养支持的患者,应每日测定尿糖 $2 \sim 4$ 次,每周测定血糖 $2 \sim 3$ 次,以便及时发现血糖异常,及早处理。

(3)肝脏损害:长期肠外营养可致肝功能损害,一般表现为转氨酶和碱性磷酸酶升高。肠外营养影响肝功能的因素较复杂,多数与营养液中的某些成分有关,如过量的葡萄糖输入、高剂量脂肪的应用、长期大量地应用氨基酸制剂等。营养液用量越大,肝功能异常的发生机会就越多,其中尤其是葡萄糖的用量。目前尚无有效的预防措施。处理主要是尽量去除或纠正诱因,积极进行护肝等治疗。近年来,富含支链氨基酸的氨基酸溶液和富含中链甘油三酯的脂肪乳剂的应用,不但使氨基酸对肝脏的损害得到控制,而且还能促使肝功能恢复,改变了以往肝病患者不能输入含氮营养素的局面。

(4)酸碱平衡失调:高糖溶液的 pH 为 $3.5 \sim 5.5$,大量输入时可影响血液 pH。氨基酸溶液中某些氨基酸(如精氨酸、组氨酸、赖氨酸及胱氨酸)的碱基代谢后可产生氢离子,导致高氯性酸中毒。特别是伴有腹泻的患者,更易产生代谢性酸中毒。少数伴有先天性代谢障碍的患者,在输入果糖、山梨醇后可出现乳酸性酸中毒。与成人相比,婴幼儿在快速输入大量糖溶液与水解蛋白时,因不能耐受高渗性溶液而更容易出现代谢性酸中毒。一旦发生此并发症应及时消除原因、对症治疗。关于代谢性碱中毒,除肾功能衰竭患者,在肠外营养中较少出现。

(5)电解质紊乱:电解质紊乱在肠外营养时较易发生,最常见的是低钾、低镁及低磷。其中要特别注意的是磷的补充,长期肠外营养治疗的患者,大量磷、钾、镁从细胞外进入细胞内,导致低磷、低钾、低镁血症。尤其是有肠外瘘的患者,更应注意补充。由于各种电解质的补充量没有固定的标准,唯一的办法是定期监测其血液浓度,因病因人及时调整补充。

(6)代谢性骨病:长期肠外营养病例中可出现骨质疏松症、纤维性骨炎、佝偻病等。

4. 肠道并发症 主要是肠道黏膜萎缩。关于肠外营养对肠道黏膜屏障功能的影响,目前正日益受到临床医生的重视。较长时期的肠外营养,特别是不能经口摄食者,容易产生胆囊结石及肠道黏膜的萎缩。后者又容易导致肠道内细菌移位,发生内源性感染性并发症。有资料提示,补充谷氨酰胺可预防肠道黏膜的萎缩,保护肠道的屏障功能。预防此并发症的唯一措施就是尽早恢复肠道营养,促使萎缩的黏膜增生,保持肠道正常功能。

四、肠外营养的监测

Given the risks and complications associated with parenteral nutrition and the fact that these patients are often critically ill and immunosuppressed, patients receiving parenteral feeding should be carefully monitored. Fluid balance, biochemical parameters, and anthropometric measurements should be performed frequently.

对肠外营养支持治疗者进行全面的监测至关重要。应根据临床和实验室监测结果,评

估观察和判断患者每日需要量、各种管道器件及疗效有关的指标,以减少或避免营养支持相关并发症,提高营养支持安全性和疗效。

(一) 临床观察

1. 每天测体温、血压,脉搏、体重,记录 24 小时液体出入量。观察生命体征是否平稳,若生命体征不平稳,则以积极纠正为先;若体温异常升高,提示有感染可能,应积极查找病因、对因治疗。

2. 观察神志改变,有无水、钠潴留或脱水,有无黄疸、胃潴留,黄疸多见于长期肠外营养所致胆汁淤积性肝病;水肿和脱水反映体液平衡情况,有助于判断营养支持的补液量是否充足或过量。根据体液平衡状况作出相应调整。

(二) 导管监测

导管皮肤出口处有无红肿感染,导管接头有无裂损,导管是否扭曲或脱出。胸部 X 线监测导管是否置入正确部位。导管插入部位应每天做局部皮肤严格消毒处理,发现导管引起感染,应将导管头剪下,送细菌、真菌培养。

(三) 实验室监测

1. 血生化测定 开始肠外营养的前 3 天,应每天测血糖、电解质(钾、钠、氯、钙、磷)。稳定后每周测 2 次。如代谢状况不稳定应增加检测次数。高血糖患者每天测 3~4 次血糖(指末法)或尿糖(试纸法)。

2. 肝肾功能 每周测 1~2 次血胆红素、转氨酶、尿素氮及肌酐。

3. 随访血常规、血浆白蛋白,凝血酶原时间等。

4. 血气分析 开始时每天测一次,稳定后在必要时监测。

5. 氮平衡 监测每日尿氮排出量,计算氮平衡。

(四) 营养评价

包括体重、上臂围、肱三头肌皮褶厚度、肌酐-身高指数、血浆白蛋白浓度、血清运铁蛋白浓度、免疫功能试验(血白细胞计数、皮肤超敏反应)等,每周测一次。

国外临床常用肠外营养监测项目见 Table 10-4-1。

Table 10-4-1 Parameters that should be evaluated during parenteral nutrition

Parameter	Daily	1-2 per week	Once every two weeks
Fluid balance	✓		
Anthropometry		✓	
Biochemical parameters:			
Hemoglobin		✓	
Leukocytes		✓	
Thrombocytes		✓	
Sodium		✓	
Potassium		✓	
HCO ₃ ⁻		✓	
Chloride		✓	

续表

Parameter	Daily	1-2 per week	Once every two weeks
Calcium		✓	
Magnesium		✓	
Phosphate		✓	
Urea		✓	
Creatinine		✓	
Alkaline phosphatase		✓	
Gammaglutamyl transpeptidase		✓	
Bilirubin		✓	
Triglycerides		✓	
Albumin		✓	
Glucose	✓	✓	
Zinc			✓
Copper			✓
Folate			✓
Hydroxycobalamin			✓
Iron			✓

Source: Michael J. Gibney, Marinos Elia, Olle Ljungqvist, et al. Clinical Nutrition, 2005

第五节 肠内营养和肠外营养的相互关系

Enteral feeding is usually considered to be the preferred route of feeding as it is more physiological as well as being cheaper and safer. However, it is increasingly recognized that enteral nutrition often fails to achieve targeted caloric requirements, especially in critically ill patients, as a consequence of poor tolerance of feeding manifested by large gastric aspirates.

Maintaining gut barrier function is often quoted as a reason for enteral feeding. However, administration of enteral nutrition to patients with disturbed GI function may cause bowel distension, delayed gastric emptying, paralytic ileum, and diarrhea.

The mode of nutritional support should be decided based on intestinal tolerance. In many instances, a combination of enteral and parenteral feeding may be necessary to meet nutritional requirements.

临床营养支持包括肠外营养与肠内营养两种途径,其内容物均包括氨基酸、脂肪、糖类、平衡的多种维生素和多种微量元素等,均系中小分子营养素,与普通的食物有根本的区别。

选择肠内营养、肠外营养或两者联合应用在很大程度上决定于患者胃肠道功能和对营养供给方式的耐受程度。通常是根据疾病的性质、患者的状态及主管医生的判断而定。如

果患者心肺功能不稳定,胃肠道吸收功能大部分丧失或营养代谢失衡而急需补偿时,应选择肠外营养;如果患者胃肠道有功能或有部分功能,则应选用安全有效的肠内营养,肠内营养是符合生理性的给养途径,既避免了中心静脉插管可能带来的风险,又可以帮助恢复肠道功能。其优点是简便安全、经济高效、符合生理功能、有多种不同的肠道营养剂。

肠内营养的补充可以通过口服、经胃、经幽门后、经空肠等多种途径给予,但对患有胃肠道疾病的患者来说选择一个合适时间、安全可靠的途径给予肠内营养并不十分容易,而且有潜在的加剧原发病的可能。一些临床症状(如恶心、饱胀感、腹痛)和体征(如腹泻、肠鸣音减弱、腹胀等)均限制了肠内营养的应用。另外,如患者不能容忍鼻胃管置入,鼻胃管置管不顺利或食管、胃术后原解剖位置变异而不能置管等,也会限制肠内营养的应用。同时,还要注意肠内营养并发症的产生,包括气管误吸、恶心、腹泻及肠道血供障碍等。所以当患者心功能处于边缘状态或血流动力学不稳定时,不应该给予肠内营养;肠内营养效果不佳的患者,应及时转换补给的方式,以免延误营养支持治疗。总之,肠内、肠外营养最关键和最重要的原则是严格控制应用适应证,精确计算营养支持的量和持续时间,合理选择营养支持的途径。

肠外营养几乎对任何经口摄食不足、不合适或不可能的消化道疾病起积极有效的辅助作用,是人类在对疾病的治疗过程中的一个重要的进步。这种疗法已经给了患有营养不良和胃肠道功能障碍等消化系统疾病的患者以巨大的好处(营养支持方式的选择见 Figure 10-5-1)。

由于肠外营养能产生饱感综合征而使胃蠕动抑制,故主张先使之轻度的饥饿数日,静脉仅输注保持水、电解质平衡的液体,以便刺激胃肠活动,同时利用条件反射,借助菜肴的色、香、味、形刺激患者的食欲,或使其与家人共餐以得到愉快等,通过管饲与经口摄食的适当配合,帮助患者从肠外营养过渡到肠内营养。从长期管饲过渡到经口摄食正常肠内营养,亦应遵循这个原则。

长期进行肠外营养,可导致胃肠道功能衰退。所以,从肠外营养过渡到经肠营养必须逐渐进行,不能骤然停止。否则将会加重肠道的负担而不利于恢复。这种过渡大致可分为4个阶段:①肠外营养与管饲结合;②单纯管饲(完全肠内营养);③管饲与经口摄食结合(以医院基本膳食为主);④从医院基本膳食过渡到正常膳食,或因病情需要长期使用治疗饮食。即宜逐渐过渡到经肠营养以使肠黏膜细胞得到适应。当患者开始能够耐受肠内营养时,先采用低浓度,缓速输注要素肠内营养制剂或非要素肠内营养制剂,监测水、电解质平衡及营养素摄入量,再逐渐增加肠内营养输注量,并以同样幅度降低肠外营养输注量,直至肠内营养能完全满足代谢需要,才可完全撤销肠外营养,过渡到完全肠内营养。随着病情和胃肠道功能的恢复,患者可逐渐增加经口摄入的营养物质,一般由流食开始,经半流食、软食过渡到普食。通常患者在过渡到半流食时已可拔去鼻饲管,完全经口摄入食物。有一部分患者出院后仍需长期坚持治疗饮食,如高血压、肥胖症、血脂异常、冠心病等患者。

上述各阶段之间的过渡期不能一概而论,必须根据患者病情和耐受力而定,一般肠外营养与肠内营养之间的过渡期为3~5天,行肠内营养支持时可同时经口摄入流食,但由肠内营养完全过渡到普食/治疗饮食至少需要一周的时间,且应避免暴饮暴食或食用油腻等不易消化的食物、刺激性食物等,否则可加重病情或使病情复发,如脑梗死者出院前因进食不当突发脑出血。

(李增宁)

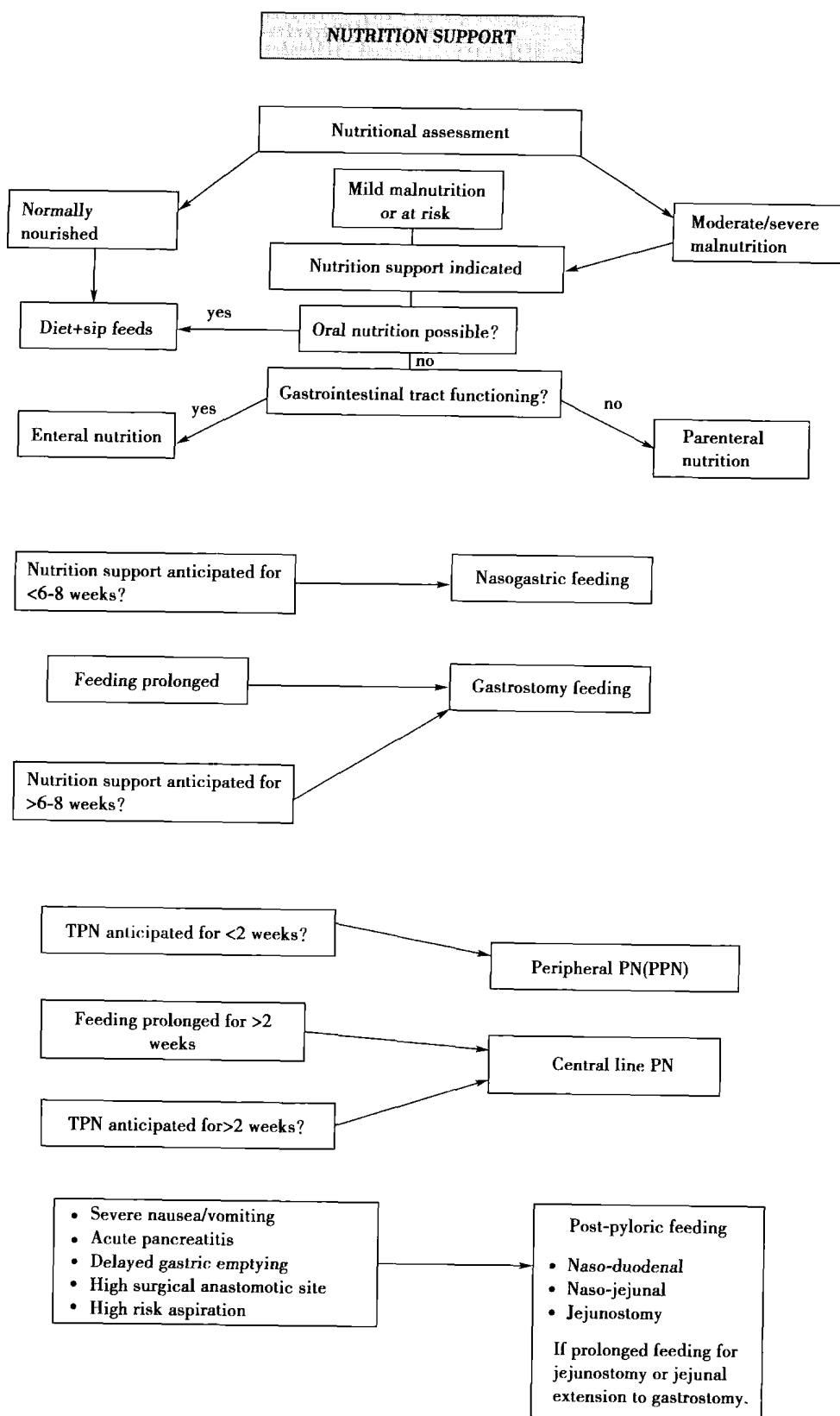


Table 10-5-1 Decision tree for deciding on optimal route for nutrition support

Source: Michael J. Gibney, Marinos Elia, Olle Ljungqvist, et al. Clinical Nutrition, 2005



第十一章 食疗与药膳

第一节 食 疗 学

一、概 述

食疗学是中华民族经过数千年实践探索和经验积累而形成的一门保健实用医学。食疗学与营养学和中医学有着紧密的联系,我们要充分发挥已有的食疗学理论和实践经验,还要继续探索食疗学与营养学、中医学之间的理论基础与作用机制,不断开发应用新的成果和技术,充分发扬、发展食疗在人类保健事业中的作用。

二、食疗学的定义和研究内容

广义的食疗学的定义是根据食药同源、医养同理的原理,利用各类食物的不同保健功效,达到防病治病、养生康复、延年益寿的目的的一门保健实用医学。可以看出,广义的食疗学的内容还包括了食养的概念。食养是饮食养身之意,就是要求人们以合理的营养促进健康长寿,防治疾病,是以预防为主。

狭义的食疗学与营养治疗学有密切的关系,它是研究如何利用食物中所含的营养素或非营养素,通过合理的加工烹调,用以治疗疾病的一门科学。它是对患者进行综合治疗的重要组成部分,与医疗、护理起着同等重要的作用。食疗能直接影响疾病的转归,或为患者接受其他治疗(如手术、毒副作用较强的药物治疗)创造必要的条件,还能增强患者体质,预防并发症的发生。

食疗学的研究内容包括食疗食养的理论和经验及其贯彻和运用,其理论基础既来源于古代著作中记载的理论和经验,也收集了民间流传的食疗食养食谱方剂,应用现代医学、营养学以及相关自然科学知识,对整理的理论和经验进行全面研究及科学验证,尽可能了解具有食疗作用的一些食物的主要成分、配伍烹调时可能发生的理化变化,阐明其获得疗效的机制,去其糟粕,取其精华,去伪存真,推陈出新,古为今用。在此基础之上,食疗学还应进一步探索研发新的功效性食品,制定更有效的食疗方剂和保健食谱,加强对重大疾病的早期食疗保健防治的研究。此外,应用食物通过非胃肠道的途径治疗各种疾病,也是食疗学的研究内容之一。

三、食疗学发展简史及特点

食物疗法在我国有悠久的历史,早在西周时代已有食医的分科。据《周礼·天官》记载,公元前一千多年的周朝,宫廷医生分为食医、疾医、疡医、兽医四科,其中的“食医”,主要掌理调配周天子的“六食”、“六饮”、“六膳”、“百羞”、“百酱”的滋味、温凉和分量,即通过调配膳食

为帝王的养生、保健服务。从食医所从事的工作来看,他们已与现代营养医生类似。同时,书中还涉及了其他一些有关食疗的内容。《周礼·天官》中说的疾医主张用“五味、五谷、五药养其病”;疡医则主张“以酸养骨,以辛养筋,以咸养脉,以苦养气,以甘养肉,以滑养窍”。这些主张已经是很成熟的食疗原则。《黄帝内经》是战国时期的医学专著,该书提出“凡欲诊病者,必问饮食居处”,要求“治病必求于本”、“药以祛之,食以随之”的治疗原则,强调“人以水谷为本”,指出“天食人以五气,地食人以五味”,“五味入口,藏于肠胃”,这里的“五味”实指各种食物分类的简称。书中还将多种食物分列于五味之下,以治五脏之疾病。在论述膳食治疗之后,它总结出“毒药攻邪,五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合而服之,以补精益气”的膳食配制原则。长沙马王堆出土的十四种西汉医学文书中,已经有了药粥治疗的方法。东汉时期的医圣张仲景,积累了极为丰富的食疗经验。他的《伤寒杂病论》中有不少食药同用的方剂,如桃花汤、白虎汤和竹叶石膏汤等。唐代名医孙思邈《千金要方》中的《食治篇》专门论述了米谷、蔬菜、果食和鸟兽四个门类食物的治疗作用。孟诜的《补养方》、《食疗本草》,南唐陈士良的《食性本草》等书,都丰富了中医食疗的内容。宋代的《圣济总录》、《太平圣惠方》中也收集了大量的食疗资料。元代吴瑞生编著了《日用本草》,其后不久,宫廷饮膳太医忽思慧又编写了《饮膳正要》。这两本书分别从不同侧面对“食疗”与“食补”作了补充。特别是后者,在药膳方面更有所发展。明代的卢和、汪颖、吴文炳皆有《食物本草》传世。《本草纲目》中收载的食疗药物不下数种,仅药粥一项就有 62 方。明清以来医家善用食治之法者如葛可久、张景岳、叶天士和吴瑭等皆有独到的经验。王孟英著有《随息居饮食谱》专门总结食疗经验。曹燕山的《老老恒言》介绍了百种药粥。近代许多名医对食疗亦各有创见,如河北盐山张锡纯先生,一贯重视食疗,广泛用以治疗痼疾,独具风格,他将山药、核桃、大葱、萝卜和鸡子黄等 30 余种食物应用于临床,并创立了许多方剂,如期颐饼、益脾饼、水晶桃、宁嗽定喘饮、硝菴通结汤等,临床应用效果显著。纵观古今,食物疗法源远流长,堪称祖国医学宝库中的瑰宝。

《备急千金要方》中说:“安生之本,必资于食,不知食宜者,不足以存身也。”饮食是维持生命的物质基础和人体代谢的能量来源。机体与外界之间最重要的联系就是食物。食物通过机体的消化、吸收和代谢影响整个机体的功能,不同的食物可产生不同的影响。食物疗法就是利用食物影响机体的功能,获得健康或治愈疾病的一种措施,食疗学也就是一门研究膳食防治疾病和保持健康的学科。食疗的优点是可以就地取材,简单易行。它还可以根据患者的饮食习惯和口味进行调制,是一种比较理想的医疗保健措施。目前,食疗学已越来越受到人们的重视,并已成为一门被广泛、深入研究的学科。

食疗学具有下述几大特点:

(一) 历史悠久,经验丰富

食疗学在我国已有三千多年的悠久历史,在这漫长的时间中,食疗学不断发展,保留了大量的文献和著作,记载了很多行之有效的食疗食养经验。据不完全统计,自商周到明清,专门或重点涉及食疗内容的书籍约为 75 册(其中 26 册已佚失),散在于各种书籍中的有关食疗食养的记载则难以计数。现存的近 50 本著作中有重大参考和应用价值的约 20 本。

我国对许多营养素缺乏疾病的认识和应用食物治疗的经验,远早于欧洲等国家和地区。我国在公元前四世纪就已经认识了地方性甲状腺肿,至公元四世纪时已能应用含碘食物进行治疗;而欧洲直至十世纪才有对阿尔卑斯山区甲状腺肿大的记载,直到近代才认识到用碘进行治疗。我国早在公元一、二世纪时编成的《神农本草》中,就记载着橘皮可治疗消化不

良,有“利水谷”作用;茶(也叫苦菜)“久服安心益气,聪察少卧”。该书还有用大枣、莲子、蜂蜜、山药、赤小豆、龙眼肉、食盐及葱白等多种食物治病的记载。卢和按《日用本草》的分类法编成了《食物本草》,该书在每一类后面都加上了总结性的跋语,如在菜类后,主张多吃蔬菜可通肠胃,有益于。在当时条件下,虽不能认识其中所含的有效成分,但却已知它对人体重要性,实在是难能可贵。高濂的《遵生八笺》,专列《饮饌服食笺》,载汤 32 种,粥类 35 种,是一部中医养生专著。徐春甫的《古今医统大全》,兼采各家之长,分科汇编,其中载汤类、鲜果、酥饼、蜜饯等许多品种,并作了较详细的论述。清代养生家曹慈山在《老老恒言》中,专为老年人编制了一百种粥谱,可谓集药粥之大成。

(二) 独特的食养卫生学说

广义的食疗学还包括了营养卫生学方面的内容,也叫做食养。食养是饮食养身之意,就是要求人们以合理的营养促进健康长寿,防治疾病,是以预防为主。清代《随息居饮食谱》的序中曾谈到:“国以民为本,而民失其教,或以乱天下,人以食为养,而饮食失宜,或以害生命……故圣人疾与战并慎,而养与教并重也。”充分强调了食养的重要性。

此外,我国古代在食养方面还非常重视“饮食有节”的观点,即节制与调节,包括四季饮食的调节、食量的节制、食物温度(寒热)的适中、食物性味的调配以及节制某些生冷有害、不洁饮食等。《内经》中“法于阴阳,和于术数,饮食有节”的论述,成为后世公认的养生准则。元代贾铭在其所撰《饮食须知》一书中说:“饮食借以养生,而不知物性有相宜相忌,丛然杂进,轻则五内不和,重则立兴祸患,是养生者亦未尚不害生也。”说明我国历来提倡饮食有节,对食养是非常重视的。

(三) 以中医理论为基础和指导原则

食疗是祖国医学的一部分,它完全建立在中医理论的基础上,并以中医理论为指导原则。古代医学通过实践,把食物如同中药一样归纳为咸、酸、苦、甘和辛五种不同的性味,研究每一味食物具有的不同医疗作用。此外,还把食物按照寒、热、温、凉四气进行归类。每种食物都有四气中的一种。食物的性味必须与人或疾病的属性相适应,否则会引起副作用。在了解各种食物的五味四气属性后,就可以按照各自身体的情况和不同病证来选择适合自己的身体状况和疾病特征的个性化食物进行对症治疗。

如体质温热者多选用性寒食物;体质虚寒者,则多选用温热食物;患热症时应忌食辛辣、醇酒等热性食物而多给凉性食物;患寒症者可食温性食物,而避忌寒冷食物。在上述中医理论指导下,食物在疾病时的宜忌就产生了。与病相宜则食,与身为害则禁。前者即食疗或食养,后者谓之“禁口”或“忌口”。某些疾病突然恶化、恢复期延长以及预后复发等,大都与食物选择不当或者恣意饮食有关。

(四) 具有鲜明的民族和地方特色

我国幅员广阔,物产丰富,各地的食疗具有独特的民族风格和鲜明的地方特色,可以利用本地特产食物和烹调特色制成单味食物、复合食疗方、养生食谱或药膳。早如汉代《金匱要略》中就有“当归生姜炖羊肉”、“百合鸡蛋黄糖水”,宋代《太平圣惠方》中的“葡萄煎”、“阳起石牛肾粥”、“蜜糖蒸百合”,《圣济总录》中的“阿胶鸡蛋汤”、“赤小豆煲鸡”、“鸡脾猪肚粥”等,《本心斋蔬食谱》有蔬食二十品,元代《饮膳正要》中的“聚珍异饌”所载食谱,都具有强烈的蒙古民族特色。总之,食疗的食物品种丰富多彩,荤素皆备,包罗万象。后人可进行更深入的探索和研究。

四、食疗学的中医理论基础

我国食疗学是祖国医学的一个分科,是以中医学理论为基础,并以之作为指导思想和实践原则。只有了解这些中医学理论,才能对食疗的具体理论和学说加深理解,知其本源所在,以利掌握运用。

(一) 以中医的阴阳五行为指导原则

中医学的阴阳五行学说是,在抵制上古鬼神巫祝迷信思想的基础上,于战国末期形成的一套朴素唯物主义的世界观体系。我国古代医学吸取了这套学说,通过医疗实践朴素地、唯物地来说明人类的生理现象、心理现象、疾病现象。《内经》中:“阳以阴为基,无阴则阳无以生,及“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也”等论述,说明了祖国医学认识到功能是依赖物质而存在这样一个唯物主义的根观点。

根据阴阳学说,人体必须保持阴阳的动态相对平衡才能维持正常的生理状态,否则就要引起病变,甚至死亡。但阴阳平衡只能是相对的,故有“阴胜则阳病,阳胜则阴病,阳胜则热,阴胜则寒”之说。《素问·生气通天论》中有“阴平阳秘,精神乃治;阴阳离决,精气乃绝”。

病分阴证、阳证,用以治疗的药物、食物也要辨认其阴阳属性,才能作针对性的调节,故以药食之味而言,“辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴;咸味涌泄为阴,淡味渗泄为阳”(《素问·至真要大论》)。而以药食之性而言,则偏热偏温为阳,偏寒偏凉为阴;按药食动力功用趋势而言,升浮之品属阳,沉降之物属阴。具体来说,寒性病证,可用温热性质药食,如葱白、生姜、饴糖、羊肉与狗肉之类;热性病证,可用寒凉药食调摄,如薏苡仁、莲心、菊花、赤小豆、龟肉与鳖肉等。

五行理论在食疗学中体现为“五味”、“五入”和“五禁”学说。《内经》中早已述及,“五味所入,酸入肝,辛入肺,苦入心,咸入肾,甘入脾,是谓五入”(《素问·宣明五气篇》)、“肝病禁辛,心病禁咸,脾病禁酸,肾病禁甘,肺病禁苦”(《灵枢·五味》)。这是依据五脏各有所喜、所恶,以及五行生克的理论衍化而来的,食疗中的许多“食忌”之品,即与五禁有关;而针对某一脏腑病证用某药食治疗,则是依据“五入”理论为指导的。

(二) 食药同源

在上古时代,食物与药物是分不开的。当时人们处于一种以觅食为生的最原始的生活状态,人们在寻找食物的过程中,也发现了一些药物。不仅如此,他们还认识到许多食物既可以食用,又可以药用,这类食物不但能补养身体、填腹充饥,还能医治一些简单的病症。也有一些能治病的中药同时具有食养作用,至今仍被视为药食兼用之品。这可以从我国最早的中药学专著《神农本草经》中得出结论。成书于东汉的《神农本草经》各论载药物和食品 365 种,按有毒无毒、养生延年与祛邪治病的不同,将食品分为上、中、下三品。

在上品之中,有大枣、葡萄、酸枣、海蛤、瓜子等 22 种食品,中品内有干姜、海藻、赤小豆、龙眼肉、粟米、螃蟹等 19 种常食之物,下品中也有 9 种可食物品。由此不难看出,在上古时期,食物与药物之间有时很难严格区分。这就是“食药同源”的缘故。所以,从广义的角度来说,食物也是药物,它与药物一样,来源于大自然,也具有四气五味的特性,也能治疗疾病。直到今天,仍有很多食物被医家当作中药来广泛使用,如大枣、莲子、芡实、山药、白扁豆、山楂、桑葚、梨子、生姜、葱白、桂圆等。同样,也有不少中药,人们也常当作食品来服用,如枸杞子、首乌粉、冬虫夏草、薏苡仁、金银花、西洋参等。

正是因为食物也是药物,药物也作食用,食物也有性味归经之分,有着良好的食养、食疗

的效果,所以,古代医家也常把食物的功用主治与药物等同起来,甚至将一味食物当作一首名方来看待。例如,牛肉作为食品,能补脾胃,益气血,古代医家就把牛肉的功效与中药黄芪画上等号。《韩氏医通》就曾直言:“黄牛肉,补气,与黄芪同功。”羊肉甘温,益气补虚,名医李东垣认为:“补可去弱,人参、羊肉之属是也。”将羊肉之功与人参并列。近代也有学者将海参,狗肉的功用比作红参。对于海参,也有著说云:“其性温补,足敌人参,故曰海参。”另外,甲鱼、鸭肉、燕窝的作用常被喻为西洋参,鸡肉(或乌骨鸡)的功效则被比作党参。民间还俗称鹌鹑为“动物人参”。一味食品喻为一首名方,古人也多有评论。如清代医家张璐在《本经逢原》中说西瓜“能解太阳、阳明中竭及热病大渴,故有天生白虎汤之称。”这是将一味西瓜比作清热名方“白虎汤”。清代名医王孟英曾说甘蔗“榨浆名为天生复脉汤”。这是将一味甘蔗汁的功用比作益气滋阴的名方“复脉汤”。梨子甘寒生津,润燥止渴,《随息居饮食谱》云:“绞汁服,名天生甘露饮。”明白了“食药同源”的道理,就可以使人们加深对食性的进一步理解,对中国人的传统饮食宜忌观有了深一层次的认识。

(三) 食物有四气

中药有四气五味及归经之说,食物也是药物,固也有寒热温凉、辛甘酸苦咸以及归经的理论。熟知食物性味归经理论,这对掌握和运用好饮食宜忌问题,有着重要意义。

所谓四气,又称四性,即寒性、凉性、温性和热性,连同不寒不热的平性,有人称为五性。了解食物的四性,就能很好地指导人们的饮食宜忌。中医认为,能够治疗热证的药物,大多属于寒性或凉性;能够治疗寒证的药物,大多是温性或热性。《神农本草经》云:“疗寒以热药,疗热以寒药。”《素问·至真要大论篇》云:“寒者热之,热者寒之。”同样的道理,凡热性或温性的食物,适宜寒证或阳气不足之人服食;凡属寒性或凉性食品,只适宜热证或阳气旺盛者食用。或者说,寒证患者或阳气不足者,忌吃寒凉性食品;热证患者或阴虚之人,忌吃温热性食物。寒与凉,温与热,是区别其程度的差异,温次于热,凉次于寒。温热性的食物多具有温补、散寒、壮阳的作用,寒凉性食品一般具有清热泻火、滋阴生津的功效。平性食品是指性质比较平和的食物。

不懂得食物之性,就很难明白饮食宜忌的道理。清代医学家黄官绣说得好:“食物虽为养人之具,然亦于人脏腑有宜、不宜。食物入口,等于药之治病同为一理,合则于人脏腑有宜,而可却病卫生;不合则于人脏腑有损,而即增病促死。”凡寒性或凉性食品,如陈仓米、小米、高粱米、薏苡仁、赤小豆、绿豆、莲子、荸荠、紫菜、冬瓜、丝瓜、苦菜、芹菜、菊花脑、马兰头、枸杞头、柿子、梨子、香蕉、西瓜、鸭肉、螺蛳、金银花、胖大海等,都具有清热、生津、解暑、止渴的作用,对热性病证或者阳气旺盛、内火偏重者为宜。反之,虚寒体质、阳气不足之人则忌食。同样道理,食品中的饴糖、姜、韭、葫、芫荽、辣椒、羊肉、狗肉、鹿肉、雀肉、茴香、砂仁、肉桂、红参、白酒等热性或温性食物,多有温中、散寒、补阳、暖胃等功效,食之能祛寒、温中或补虚,对阳虚怕冷、虚寒病症,食之为宜,热性病及阴虚火旺者忌食之。人乳、粳米、粳米、大豆、蚕豆、扁豆、麻油、荠菜、青鱼和橘子等则为平性之物;无寒温之偏则具健脾开胃、补益身体作用。

此外,食性还要与四时气候相适应,《素问·六元正纪大论篇》云:“用凉远凉,用热远热,用寒远寒,用温远温,食宜同法。有假者反之,此其道也。”这就是说,寒凉季节要少吃些寒凉性食品,炎热季节要少吃些温热性食物,饮食宜忌要随四季气温而变化。这又是中医学的“天人相应”观。

总而言之,食性犹如药性,饮食宜忌要根据食物之性,结合身体素质、疾病性质、四时气

温变化而灵活掌握,合理选择,科学搭配。

(四) 食物分五味

五味指辛、甘、酸、苦、咸,另有淡味(淡附于甘)与涩味(涩附于酸),其中又以辛、甘、淡属阳,酸、苦、咸属阴。不同的味有不同的作用和功效。

1. 辛味 辛味有发表、宣散、行气、活血等作用,适宜有外感表证或风寒湿邪者服食。近代研究认为,辛味可促进胃肠蠕动,增强消化液分泌,增强淀粉酶的活性,促进血液循环和新陈代谢,并有祛散风寒、疏通经络的功能。该味食物有葱、姜、大蒜、萝卜、辣椒、桂皮、丁香等。

如外感风寒感冒者,宜吃具有辛辣味的生姜、葱白、紫苏等食品以宣散外寒;对寒凝气滞的胃痛、腹痛、痛经之人,宜吃辣椒、茴香、桂皮等辛辣食品以行气、散寒、止痛;风寒湿痹患者宜饮用辛辣的白酒或药酒,借以辛散风寒、温通血脉。用白胡椒、绿豆等研成细末,温黄酒送服,可治心腹冷痛;花椒、生姜合大枣水煎服汁,治寒凝气滞所致的痛经,则为辛味能发散寒邪、通利气血之功;酒多辛热,亦有辛散、行气、活血、通络之效。

2. 甘味 甘味食物如糯米、饴糖、大枣、南瓜、荔枝、龙眼以及鱼肉、动物内脏之类,有补益、和中、缓急作用,虚损性疾病或筋急疼痛之症多用之。如糯米红枣粥治疗脾胃气虚或胃阳不足;糯米酒和鸡蛋煮熟后服以调治产后体虚;大枣黄芪煎汤饮用治气血亏虚等。此外如羊肝、牛肝、鸡肝等治肝血不足所致之夜盲或视物昏花病症;羊骨、牛筋、牛鞭、猪脊髓等治肝肾亏损引起的腰膝酸软、骨弱无力、阳痿早泄或筋骨挛痛诸症,都是十分有效的。

甘味有补益强壮作用,凡气虚、血虚、阴虚、阳虚以及五脏虚羸者,适宜多吃味甘之品。甘味虽能补充气血,又能消除肌肉紧张和解毒,但若过吃甜食,则易发胖,是很多心血管疾病如动脉硬化症的诱因,故这类患者及糖尿病患者又当忌吃甜物。

3. 酸味 酸味有收敛、固涩作用,适宜久泄、久痢、久咳、久喘、多汗、虚汗、尿频、遗精、滑精等遗泄患者食用。酸味还能增进食欲、健脾开胃、增强肝脏功能,提高钙、磷吸收率。“酸甘化阴”,与甘味食物合用,能滋阴润燥。如乌梅酸涩,可涩肠止泻、安蛔止痛;与饴糖配合成酸梅汤,则酸甘化阴,生津止渴,是清热解暑上乘饮料。莲子、芡实也带涩味(甘、涩、平),有补脾止泻益肾固精作用,对于脾虚久泻、肾虚遗精及妇女带下者,可作常服之品。但过食酸物,又会导致消化功能紊乱。

4. 苦味 苦味食物有清热、通泄、燥湿、降逆作用,可治热、湿、气逆等证。例如,苦瓜味苦性寒,用苦瓜炒菜,佐餐食用,能达到清热、明目、解毒、泻火的效果,适宜热病烦渴、中暑、目赤、疮疡疖肿者服食。苦菜食之可清火、退黄、解暑及治小便赤痛、淋症。茶叶也属苦甘而凉性味,也具有清泄的功效,适宜夏日饮用,有清利头目、除烦止渴、消食化痰的好处。

5. 咸味 咸味能软坚,能散结,也能润下,凡结核、痞块、便秘者宜食之。具有咸味的食物,多为海产品及某些肉类。如海蜇,其味咸,有清热、化痰、消积、润肠的作用,对痰热咳嗽、痰核、痞积胀满、小儿积滞、大便燥结者,食之最宜。猪肾味咸性平,能治肾虚所致腰痠遗精,小便不利等症;鸽肉甘咸,能补肝肾、益精血;海参甘咸而温,可润燥通便,配以木耳则治阴虚肠燥所致之便秘;海带、紫菜咸寒,能软坚散结,消痰利水,民间常用于治疗瘰疬(颈淋巴结结核)、瘰疬等病症。

再如常食之物猪肉,其味咸,除能滋阴外,也能润燥,同样适宜热病津伤、燥咳、便秘之人食用。清代名医王孟英还说,治“液干难产,津枯血夺,火灼燥渴,干嗽,便秘,并以猪肉煮汤,吹去油饮”。这些都是咸能润下软坚的效果。

6. 淡味 淡可渗湿、利尿,此类食物最多,如白扁豆、淮山药、冬瓜、花生、豌豆、白菜、芹

菜、藕、鸡蛋、鲫鱼和青鱼等。白扁豆与淮山药同煮或单独食用,均有健脾利湿之效,可治脾虚便溏及妇女白带过多。冬瓜煮鲤鱼,葱白佐膳,利尿消肿效果显著。薏苡仁甘淡微寒,健脾、利湿、退肿,可煮粥食。

中医的五味学说还包含五味与五脏的密切关系。如《素问·宣明五气篇》说“五味所入:酸入肝,辛入肺,苦入心,咸入肾,甘入脾,是谓五入。”《灵枢·五味论》还说“五味入于口也,各有所走,各有所病。”《灵枢·五味》:“肝病禁辛,心病禁咸,脾病禁酸,肾病禁甘,肺病禁苦。”祖国医学理论认为,肺主气,心主血脉,肝主筋,脾主肉,肾主骨,饮食五味用之适宜,对人体则有益处,若因过分偏嗜则可发生疾病。或在五脏有病之时,也应适当调整饮食五味。《灵枢·五味论》中就说:“酸走筋,多食之,令人癢;咸走血,多食之,令人渴;辛走气,多食之,令人洞心;苦走骨,多食之,令人变呕;甘走肉,多食之,令人悦心。”《素问·宣明五气篇》也说:“辛走气,气病无多食辛;咸走血,血病无多食咸;苦走骨,骨病无多食苦;甘走肉,肉病无多食甘;酸走筋,筋病无多食酸。”如不注意或不重视这些宜忌原则,强行多食,百病由生。正如《素问·五脏生成篇》中所说:“是故多食咸,则脉凝泣而色变;多食苦,则皮槁而毛拔;多食辛,则筋急而爪枯;多食酸,则肉胝胸而唇揭;多食甘,则骨痛而发落,此五味之所伤也。”由此可见,食物的五味,直接关系到人体的健康长寿。饮食物的五味宜忌,不仅要与食物的四气、归经相结合,还要考虑到季节变化、病情性质和身体素质,成为一种综合性的五味宜忌理论。中国传统医学的食物五味理论,是指导传统饮食宜忌的重要依据。五味调和,脏腑得益,人体健康;五味偏嗜,或不遵宜忌,将导致五脏失调,形成疾病。

(五) 食物可归经

中医对食物的认识,不仅要比近代医学营养学对食物的认识历史悠久,而且要全面深刻得多。除了上述食物性味学说之外,食物归经理论也同样表明了中医对食物调理养生的认识更加深入而科学。慢性病患者可能体会到,当有肺虚咳喘之时,有经验的老中医往往建议患者经常吃些百合、山药、白果、燕窝、银耳、猪肺、蛤蚧或冬虫夏草等补品,而不会叫你去吃桂圆肉、栗子、芡实、莲子、大枣等,这是因为前者食物皆入肺经,能养肺、补肺、润肺,后者皆不入肺经,食之于肺无补;肾虚腰痛腰酸之人,老中医多半劝食栗子、胡桃、芝麻、山药、桑葚、猪腰、枸杞子、杜仲等,而不会介绍你去吃百合、桂圆肉、大枣、银耳、白人参等补品,这同样是因为前者都能入肾经而补肾壮腰,后者皆不入肾经,非补肾之物,食之于腰酸、腰痛无补。这就是中医所说的食物归经理论。

食物归经,是指饮食物对于机体各部位的特殊作用。食物对人体所起的作用,有它一定的适应范围。如寒性食物,虽同样具有清热的作用,但其适应范围,或偏于清肝热,或偏于清肺热,各有所专。同为补物,也有补肺、补脾、补肾等的不同。以清热泻火食物为例,一般都属寒性或凉性食品,但有的偏于清肺热,有的偏于清心火,有的偏于清肝热。如梨子、香蕉、柿子、桑椹、芹菜,莲心、猕猴桃等,均为寒凉食物,但梨子、柿子偏于清肺热,香蕉偏于清大肠热,桑椹偏于清肝虚之热,芹菜偏于清肝火,莲心偏于清心热,猕猴桃偏于清肾虚膀胱热,这都是由于归经不同。同为补益食品,猪心、桂圆肉,柏子仁,小麦则入心补心,养心安神,心悸失眠者宜之。山药、扁豆、糯米、粳米、大枣等入脾、胃经,故能健脾养胃,脾虚便溏者宜之。食物同药物一样,有一药归两经或三经,也有一食归两经或三经。如山药能归肺经、脾经和肾经,故凡肺虚、脾虚及肾虚之人均宜食之。桑椹归肝经和肾经,肝肾阴虚者宜之。莲子一物入心、脾、肾三经,故心虚失眠多梦、脾虚久泻带下、肾虚遗精早泄者,均宜食之。

综上所述,食物的四气、五味、归经等学说,是中国传统饮食宜忌的重要理论依据。中医

认为食物的养生调理作用,绝非专指珍奇美味,也不只是讲“营养素”有无多寡,而是根据病证、病位、病性和患者年龄、性别、身体素质类型及四季天时、地理因素,结合食物的性味归经的理论,来分析并选择食物的宜与忌。这种丰富多彩、辨证科学的饮食宜忌观,在近代营养学和西医理论中是没有的。

(六) 以气血津液为食疗调养的基础

中医理论认为人体基本生命活动物质是气、血、津液,它们流行、润泽、营养于全身,并完成各种生理功能。它们最精华的部分称为“精”。这些生命物质不断消耗,需要持续补充。由于活动多、功能复杂,最易受到损伤。除“先天之精”外,还可靠“后天之精”及时补充和调摄。即使是肾所藏的“先天之精”,一旦有了匮乏或损伤,也可以通过食物加以补充。例如“血肉有情之品”的鹿茸、鹿肉、鹿血之类,是常用来补充阳精的。在食疗中用药食补充血或津液之不足尤为常见,如大枣、龙眼肉、荔枝、芝麻、猪血、鸡血、猪肝和鸡肝等可补血;鲜芦根、甘蔗汁、生荸荠、鸭梨和西瓜等可生津,而鳖肉、龟肉等可以增液;薏苡仁、赤小豆、扁豆、萝卜子、杏子、白果和橘皮等则具利水、化湿、祛痰、消饮等功效。

(七) 维护脏腑功能是食疗调养的关键

气血津液及精等基本生命物质的功能活动,主要反映在身体五脏六腑的生理功能上。如果脏腑功能正常,机体则健康。食疗的主要作用是调整脏腑功能。如心若气血不足,或为痰浊、邪热等所扰,心主神志的功能会出现异常,见失眠、多梦、神志不宁、反应迟钝、健忘等症,甚至谵妄昏迷。食物中大枣、龙眼、小麦、莲子、蛋黄等有养心安神功效,可以辅服。肺的宣发功能失常,每见呼吸困难、胸闷、咳嗽及鼻塞、喷嚏、恶寒、无汗等症,食物及调味品中的生姜、葱、桂皮、芫荽、薄荷叶等有宣肺发表之功效,为治感冒之良药。脾胃虚弱,则可用扁豆、山药、粳米、薏苡仁、山楂、蚕豆、萝卜、大枣、辣椒和茴香等以健脾和胃。狗肉、鹿肉和牛鞭等可温肾阳,龟肉、鳖肉和海参等可滋补肾阴,牛骨髓、猪脊髓等可填补肾精。

(八) 辨证论食是食疗调养的准则

辨证,即是根据每个人的不同状况,综合地作出其疾病部位、证型诊断,以便有的放矢地给予相应药食处方,预防或治疗疾病。中医辨证方法很多,最基本的是“八纲辨证”,即将患者的症状、体征从阴阳、表里、寒热、虚实8个方面加以归纳,得出综合判断,或为阳虚,或为里热,或为阴虚,或为表寒之类,并与脏腑、经络等部位相联系。用药治疗称“施治”,用食物治疗则称“施食”。

食物治疗时宜辨证施食,应根据以下原则进行。

1. 根据机体情况选食气相投之品 无病之人,阴平阳秘,气血阴阳调整,饮食起居正常。有的人临床虽无任何病象表现,但其内在阴阳已有不平衡之处,体质已有偏寒偏热的倾向,所进食物要寒热适宜,才能达到调治阴阳的效果。《圣济总录》载有:“精顺五气以为灵,若食气相恶,则为伤精,形受五味以成体,若食味不调,则为损形。”体质偏寒者宜食热性食物,如葱、韭、蒜、姜、椒、桂圆和酒等,少食生冷偏寒之品;体质偏热者,宜食凉性食物,如绿豆、芹菜、马兰头、瓜果和芦根等,少食辛燥温热之物;体胖之人,食欲亢进者多,为能饱腹可多食用富含纤维素的蔬菜,如芹菜、韭菜、笋和草头等食物,也可常食荷叶粥,清凉可口,助降血压血脂;体瘦之人,要多食用含淀粉高、补脾胃的食物,如山药粥、马铃薯饼和扁豆红枣粥等。

2. 根据所患疾病的性质、表现选食 在食物治疗时,应按八纲辨证分清表里、寒热、虚实、阴阳,也要注意正治与反治、标本缓急、脏腑补泻和八法运用,但不像药物治疗那样严格。

(1) 正治与反治:正治也称逆治法,是最常用之法,如寒者温之、热者凉之、虚者补之和实

者泻之。如外感风寒的表证有头痛、鼻塞、畏寒、全身酸痛及无汗等症状,可用生姜、葱白和红糖等温热食物,煎汤热服,或大蒜末拌热面、芫荽黄豆汤(芫荽 30g,黄豆 50g),发汗解表以散寒;若外感风热,有头胀、咽痛及轻咳等症,则可用桑叶、菊花、薄荷和罗汉果等凉性食物泡茶饮用,或服丝瓜汁等宣透表邪。

反治也称从治法,在特殊情况下采用,如塞因塞用,由于脾气虚引起腹胀,可用山药、莲肉、芡实等煮粥,以补气开塞。

(2)标本缓急:标与本是两个相对概念,一般认为标是疾病表现于临床的现象所出现的证候,本是疾病发生的病机,即疾病的本质。中医一般按“急则治其标、缓则治其本”和“间者平行,甚者独行”的原则进行治疗,一些慢性病多从治本着手。如脾虚所致的鼓胀,鼓胀为标,脾虚为本。若胀得不甚,可治脾虚以消胀,但当鼓胀明显,腹水很多,二便不利,就先逐水利尿,用黑白丑、车前子、玉米须等,候水去病缓,再予健脾固本。间者平行,是指标本俱急情况下,必须标本同治,如咳喘:胸满、腰痠、尿少、全身尽肿等证候,其病之本为肾虚水泛,病之标为风寒束肺,治疗时则应发汗解表,补肾利水,表里双解,可食生姜、杏仁炖黑鱼汤。

(3)脏腑补泻:人体是有机整体,脏腑之间互相联系、相互影响,往往一脏有病则影响他脏,而他脏有病也会影响原发病的脏腑,可按五行生克关系,作为治疗上的补泻原则。

1)虚则补其母:如脾与肺是母子相生关系,脾为肺之母,肺为脾之子,肺气不足易有外感,动则汗出,气短咳嗽等症状,治疗时除补益肺气之外,常用益气健脾之法使之食欲增加,肺气也得谷气所养,久之,疾病自愈。此即常用“培土生金”法,所进食物如山药、扁豆、米仁、芡实与红枣等。

2)实则泻其子:如肾为肝之母,肝火亢盛,影响肾的封藏功能而引起遗精、梦泄,治疗时就不能补肾,而要清泻肝火。肝火得平,则肾的封藏功能也恢复,梦遗可随之而愈。所取食物如菊花、决明子泡茶,地耳烧汤服均能清肝泻火。

3)壮水制阳:适用于肾之真阴不足的证候。以填补肾之真阴来消除因肾阴不足不能制阳所引起的一系列阳亢证候,如头晕、目眩、舌燥、咽痛等,可食枸杞子和叶,桑椹子、生熟地、甲鱼等食物,滋肾水以涵木,解除肝阳上亢的证候。

4)益火消阴:适用于肾之真阳不足的证候。以滋补肾阳来消除因肾阳不足、无力温煦气化所引起的一系列阴凝之证,如腰酸、膝软、肢冷、胃寒、尿频或不利、水肿、便溏等证候,可食狗肉、兔肉、雀肉、羊肉、羊肾和韭菜子等补肾阳之物,暖腰膝、益肾壮阳以消阴翳。

(4)八法运用:汗、吐、下、和、温、清、消、补为中医八种基本治法,除吐法少用外,其他均常应用,并有所发展。

1)汗法:多用于外感疾病,使通过发汗解除表邪。葱、姜、蒜等辛辣之物均可助汗。

2)吐法:少用。

3)下法:指通泻大便以祛除病邪。有攻下、润下、导滞、逐水、攻痰等。如老人气血不足,肠燥便秘,可用蜂蜜、麻油、香蕉或菜泥等食物润肠通腑。小儿痰多可用莱菔子、苏子或葶苈子等煎汤服用以攻痰,使痰由大便排出。

4)和法:指调整人体功能以解除病邪。如人到更年期常有乍寒、乍热,汗出时有时无,情绪易于波动等自主神经紊乱的证候,中医认为是营卫不和,可用生姜、大枣、甘草和淮小麦等调和营卫。

5)温法:指用温热食物振奋阳气、祛散里寒,多用于体质偏寒或证属寒性的人。如平时畏寒,稍食生冷则脘痛腹泻者可常食桂圆肉、枣、姜、羊肉或黄酒之类。

6)清法:指用寒凉食物清内热、除毒火,常用于体质偏热或证属热性的人,如平时口干津少、咽痛、便干,常有鼻燥、鼻出血等,可常食凉性生津食物,如荸荠、梨、藕、香蕉、甘蔗、茅芦根、马兰头、白木耳等,发高热可用冷饮以助机体散热,使体内环境适应。

7)消法:指用食物消除体内有害物质,包括消食、化痰和化瘀等。如饮食不化可用麦芽、山楂或神曲以消食,也可用鸡内金焙干研粉与面粉、炒芝麻做成脆饼服用;痰多可用陈皮泡茶饮;鳖甲、甲鱼滋阴潜阳、软坚散结,能抑制肝脾结缔组织的增生;海带、紫菜消瘰瘤(甲状腺肿)。

8)补法:指用有补益作用的食物或药物补养气血、强壮功能。名医陶弘景用猪心治心悸怔忡,夜不成寐者,与当归、人参同煮效果更佳。其他如莲子、桂圆、淮小麦亦补心,红枣炖羊心,补心安神治惊悸,各种肝均可补血治雀盲,枸杞子、桑椹子、熟地等补肝肾之阴,山药、莲肉、龙眼肉、白扁豆、赤小豆、薏苡仁猪脾粥均可补脾养胃,百合、白木耳、冬虫夏草、猪肺、柠檬叶等可补肺,胡桃粥、栗子粥补肾亏等。

3. 因时因地,灵活选食 一年四季气候不断变化,对人的机体也有一定的影响。《饮食膳要》中有“春气温宜食麦以凉之,夏气热宜食菽以凉之,秋气燥宜食麻以润其燥,冬气寒宜食枣以治其寒”。我国民间食粥也随四季变化而不同。如春天气候温暖,万物生长蓬勃,应多食菜粥,如荠菜粥;夏季气候炎热,多雨湿重,应多食绿豆汁、薄荷汤、荷叶粥、藿香羹、西瓜、冬瓜等清暑利湿;秋天气候转凉干燥,应食藕粥或地耳粥以润养;冬季天寒,万物封藏,应食羊肉粥、八宝粥、桂圆枣子粥等以温补身体精气。

4. 食贵有节,食不欲杂 不可因某些食物对自己有益或喜食而饱腹无度。也不可急于取效,一次进食量太多。否则会损伤脾胃,有害无益。《内经》中就提到:“饮食有节”、“忽使过之,伤其正也。”

食不欲杂,是指在同一时间内,不要进食品种过多,因食有五味,五味入于口,各有所走。《备急千金要方》中引用语:“食不欲杂,杂则或有所犯,有所犯者,或有所伤,或当时虽无灾苦,积久为人作息。”众所周知,蟹与柿子不能同食(少食无妨),否则会腹痛、腹泻。因为蟹肉富含蛋白质,柿子性寒,含鞣酸多,蛋白质遇鞣酸则凝固成不易消化的硬块,积在肠胃内刺激肠壁,故有腹痛、腹泻。

五、食疗的原料选择

1. 广义的食疗原料选择 凡是日常人们饮食所用的食物类,都属于食疗的可选原料,不论是五谷杂粮,或豆类、小杂粮、水果及其干果类、各类蔬菜,都可用作食疗的选料。此外动物类的禽兽,家畜或水产海味皆在选料的范围之内。

2. 狭义的食疗原料选择 在这类原料中往往牵涉到中草药类的药食并用之品,例如,山药既属日常生活用的食品,也是补肾健脾的良药;贝母、苦杏仁经过炮制,便成了祛痰镇咳的有效药膳;阿胶是驴皮加工而成的,配伍乌鸡肉则具有良好的补血养血和美容的效果。综观中草药类的药食原料,不少于200余种,据研究表明,常用的中草药一般有600余种,其中1/2就是食用之品。如果配伍其他食物,加工成药膳,则其种类便相当可观了。

3. 调料和饮料类原料 人们日常生活所用的糖、酒、油、盐、酱、醋等均属食疗的配料,尤其酒类以及各类香味品配伍于药膳内的调味品,则能增加食疗的美味,并可提高成品的功能,故尤为人们所欣赏。各类蜂蜜、蔗糖都是运用于食疗的制作工艺的佳品。此外,非蔗糖类的甜味剂,如蛋白糖、甜叶菊等是近代科学特制的新型调味品,实际采用于食疗中可为食疗增辉的效果,某些禁忌用糖或不想吃糖者(如糖尿病患者等),便多了一类调味的选择。

第二节 药膳学

一、概述

药膳是以药物和食物为原料,经过烹饪加工制成的一种具有食疗作用的膳食。药膳学是祖国医药学的一个重要组成部分,是中华民族历经数千年不断探索、积累而逐渐形成的独具特色的一门临床实用科学,是中华民族祖先遗留下来的宝贵的文化遗产。中医药膳学是与中医药学理论密切相关并同步发展起来的,对防病治病有着重要的作用。同时,中医药膳也吸取了现代营养学观点,且将二者有机地统一,提高了单纯应用时的治疗效果。

二、药膳学的定义和研究内容

药膳学是在中医传统“食疗”的基础上发展而成的较系统的中医药分支学科。药膳学是根据治病、强身、抗衰老的需要,在中医药理论指导下将中药与某些具有药用价值的食物相配伍,并采用我国独特的饮食烹调技术和现代科学方法制作而成色、香、味、形俱全的食品。它“寓医于食”,既具有营养价值,又将食物赋以药用;药借食力,食助药威。以此达到营养养生和防病治病、保健强身、延年益寿的目标的一门保健医学。它是中国传统的医学知识与烹调经验相结合的产物。药膳学作为中医学的重要组成部分,为中华民族的繁衍昌盛和人民体质的增强作出了重大贡献。

药膳既不同于一般的中药方剂,又有别于普通的饮食,是一种兼有药物功效和食品美味的特殊膳食。它可以使食用者得到美食享受,又在享受中使其身体得到滋补,使疾病得到治疗。中国传统药膳的制作和应用,不仅是一门科学,更可以说是一门艺术。

药膳学的主要任务是通过药膳发展史、药膳配制理论与方法、药物和食物的性能以及药膳的经营管理的研究,使传统的“食疗”不断改进、提高并加以推广,使之社会化、工业化、商品化,更有效地为医疗事业服务。

三、药膳学的发展简史

在我国,自文字出现以后,甲骨文与金文中就已经有了“药”字与“膳”字。而将“药”字与“膳”字连起来使用,形成“药膳”这个词,则最早见于《后汉书·列女传》,其中有“亲调药膳,恩情笃密”这样的字句。以后,在《魏书·外戚》中又出现了“灵太后亲侍药膳”的字句。《宋史·张观传》还有“蚤起奉药膳”的记载。这些记载证明,至少在一千多年前,我国已出现“药膳”其名。而在药膳一词出现之前,在我国的古代典籍中,又早已出现了有关制作和应用药膳的记载。

《淮南子·修务训》记载:神农“尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所避就”。这表明,在远古时代,中华民族就开始探索食物和药物的功用了。现代考古学家已发现不少原始时代的药性食物。民族学研究也发现一些处于原始时代的民族会烹制药用食品。这些都证明,药膳确实可以说起源于人类的原始时代。当然,这种原始的药膳雏形,还不能说是真正的药膳。那时人们还不是自觉地利用食物的药性,真正的药膳只能出现于人类已经有了丰富的药物知识和积累了丰富的烹饪经验之后的文明时代。那么真正意义上的药膳在我国究竟起源于何时,又是如何发展演变的呢?

我国早在先秦时代,甚至可能在西周时代,就有了相当丰富的药膳知识,并出现了从事药膳制作和应用的专职人员。春秋战国时期,就有了饮食营养法研究,而且形成了制度。据统计,《黄帝内经》中共有 13 首方剂,其中 6 首属于药膳方剂。

秦汉时期的经济文化发展很快,从而加速了药膳研究的进程。秦始皇、汉武帝都是贪求长生不老的帝王,他们要太医、方士去寻求长生不老的药物和膳食,这大大地促进了药膳的形成和发展。东汉末年所出的我国现存最早的药书《神农本草经》,载药 365 种,书中根据药物性能和使用目的不同而将药物分为上、中、下三品,其中上药一百二十种为君,主养命以应天,无毒,多服久服不伤人,欲轻身益气不老延年者,本《上经》。中药一百二十种为臣,主养性以应人,无毒有毒,斟酌其宜,欲遏病补虚羸者,本《中经》。下药一百二十五种为佐使,主治病以应地,多毒,不可久服,欲除寒热邪气、破积聚,愈疾者,本《下经》。“上品药中的大枣,人参、枸杞、五味子、地黄、薏苡仁、茯苓、沙参,中品药中的生姜、葱白、当归、贝母、杏仁、乌梅、鹿茸,下品药中的附子等,均常用于制作药膳。

魏晋南北朝时期,药膳理论有了长足的发展,出现了一些专门著述。晋代葛洪的《肘后备急方》中记载了许多食疗药膳性质的民间简便方,如海藻治癭病,羊肝治雀盲等。梁代养生家陶弘景对药物和食物进行了分类。北魏崔浩的《食经》、梁代刘勰的《食方》等著述对中国药膳理论的发展起到了承前启后的作用。

唐代,中国药膳不但在理论上得以系统发展,在应用方面也更为广泛。唐代名医孙思邈在其所著的《备急千金要方》中共收载药用食物 154 种,载有药膳食疗方 117 首。并且明确指出:“安身之本,必资于食”,“夫为医者,当须先洞晓病源,知其所犯,以食治之;食疗不愈,然后命药”,“食能排邪而安脏腑,悦神爽志,以资血气”,并认为“若能食用食平疴,释情遣疾者,可谓良工。长年饵老之奇法,极养生之术也”。孙思邈的弟子孟诜集前人之大成,编成《补养方》一书,共收载 241 种药用食物。孟诜的弟子张鼎又将《补养方》增补 87 条,改为《食疗本草》,是我国现存最早的食疗专著,对后世影响较大。唐代咎殷编著了《食医心镜》,书中以食物药品为主,组成药膳食疗方 211 首,治疗各种疾病;南唐陈士良把《神农本草经》、《新修本草》、《本草拾遗》等书中有关饮食的药物加以整理分类,把食疗药膳与四时饮食联系起来,附以己见,著《食性本草》十卷。该书对药膳作了较为系统的总结,为药膳的发展作出了很大的贡献。遗憾的是该书早已亡佚。

到了宋代,中医食疗药膳更受重视。这一时期出现了食疗药膳治老年病的专著,如陈直的《养老奉亲书》,元代邹铉加以补充,更名为《寿亲养老新书》。全书载方 231 首,其中食疗药膳方达 162 首,占 70% 以上,把食疗法列为治疗老年病的首要方法。宋代官修大型方书《圣济总录》中,载有药膳专论食治一门,共有食疗方剂 285 首,在食疗的制法和剂型上,又有新的发展。

随着历史的发展,药膳已愈趋于成熟,到了元代,我国医学在营养学方面已相当丰富多彩。元代饮膳太医忽思慧编撰的《饮膳正要》是一部典型的药膳专著,该书继承了食、养、医结合的传统,十分重视药物与食物的滋补和治疗价值。明清药膳著述更为丰富多彩,对各种食疗方剂、药物和食物的性味功用的研究都有很大发展,在应用上更加广泛和普及,特别是药膳的烹调和制作,达到了极高的水平。明代李时珍药物学巨著《本草纲目》突破了古代本草分类方法的约束,增列了水、火、土、服器部。它把水部列为首部,指出:“水为万化之源,土为万物之母。饮资于水,食资于土。饮食者,人之命脉也,而营卫赖之。”所载 444 种动物药中,有许多可供药膳使用,且营养十分丰富,疗效也甚高。书中还记载了食物烹调与药物、食